

• 标准与规范 •

艾滋病相关慢性腹泻中西医协同治疗专家共识^{*}

中华中医药学会防治艾滋病分会

摘要: 艾滋病腹泻作为艾滋病患者常见的并发症之一,其病程较长、反复发作、缠绵难愈、病情较重,严重影响艾滋病患者的健康。西医治疗采用补液、抗生素、微生态制剂等方法。中医辨证治疗:脾胃虚弱证:治法:健脾化湿。推荐方药:参苓白术散加减。推荐中成药:参苓白术散。寒热错杂证:治法:清热散寒,辛开苦降,补气和中,扶正祛邪。推荐方药:半夏泻心汤加减。推荐中成药:乌梅丸。脾肾阳虚证:治法:温补脾肾,固涩止泻。推荐方药:加味赤石脂禹余粮汤合四神丸加减。推荐中成药:四神丸。临证应做到中西医优势互补,提高艾滋病相关慢性腹泻中西医结合诊疗的规范化。

关键词: 艾滋病; 艾滋病相关腹泻; 协同治疗; 专家共识; 高效抗反转录病毒治疗

DOI: 10. 16368/j. issn. 1674 - 8999. 2021. 04. 165

中图分类号: R259. 129. 1 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674 - 8999(2021)04 - 0773 - 03

Consensus of Integrative Medicine Experts on AIDS-related Chronic Diarrhea

Anti-AIDS Branch of China Association of Chinese Medicine

Abstract: AIDS diarrhea, which is one of the common complications of AIDS patients, has long course. With repeated attacks as well as lingering and difficulty to heal and the severe situation, the health of AIDS patients are seriously affected. Fluid infusion, antibiotics, and microecological preparations are used in Western medicine treatments. TCM treatment is carried out with syndrome differentiation: for Spleen and Stomach deficiency syndrome, clinical treatment of invigorating Spleen and dissipating Dampness are used. The recommended formula is modified Canling Baizhu Powder and the recommended Chinese patent medicine is Canling Baizhu Powder; for Cold-Heat complex syndrome, the treatment is clearing away Heat and dispelling Cold, spreading Qi with acrid drug and downbearing Qi with bitter drug, replenishing Qi and neutralizing Spleen and Stomach, strengthening the body's Zheng Qi and eliminating the evil factors. The recommended formula is Banxia Xiexin Decoction and the recommended Chinese patent medicine is Wumei Pills; for Spleen and Kidney Yang Deficiency Syndrome, the treatment method is warming Spleen and Kidney as well as strengthening astringent power to stop diarrhea. The recommended formula is modified Chishizhi Yuyuliang Decoction combined with Sishen Pills and the recommended Chinese patent medicine is Sishen Pills. To improve the standardization of integrative medicine diagnosis and treatment of AIDS-related chronic diarrhea, the advantages of Chinese and Western medicine should complement each other in clinical diagnosis.

Key words: AIDS; AIDS-related diarrhea; integrative treatment; consensus of experts; highly active antiretroviral therapy (HAART)

慢性腹泻是艾滋病发生发展过程中最常见的并发症之一,主要是患者感染人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)后,免疫系统功能下降而引发的消化系统肠道黏膜屏障完整性破坏、吸收障碍导致。中国发病率达 30% ~ 80%,在某些落后的发展中国家甚至可达 90%^[1]。慢性腹泻可导致艾滋病患者的病死率显著增加,通常还伴有不

同程度的吸收障碍、营养不良,严重影响艾滋病患者的生活质量,因此是艾滋病患者生存的独立负性预测因子,其诊治问题始终是该研究领域的热点。

腹泻根据病因可分为感染性腹泻和非感染性腹泻。感染性腹泻常见的致病微生物有细菌、病毒、真菌、原虫等,其中细菌性感染尤其是革兰阴性菌的肠道感染,在 HIV 感染者中为普通人群的 20 ~ 100 倍,隐孢子虫等原虫感染也是艾滋病相关腹泻常见

^{*} 基金项目: 中医药行业科技专项项目(201507005)

诱因^[2]。非感染性腹泻主要由 HIV 病毒所致肠病、脂肪吸收障碍引起。某些抗病毒药物(如替诺福韦、替拉那韦、洛匹那韦利托那韦片等)、肿瘤亦会引起腹泻^[3]。

随着高效抗反转录病毒治疗(highly active antiretroviral therapy, HAART)的普遍运用和人体免疫机制的重建,艾滋病相关腹泻的发病率大幅度下降。但因艾滋病相关腹泻病因、病原学及机制复杂,临床针对艾滋病慢性腹泻的病原学治疗及对症止泻药物(如奥曲肽、易蒙停、苯乙哌啶等)的西药治疗往往疗效欠佳,易反复。中医药治疗讲究整体观念、辨证论治,在临床中取得了较好疗效。慢性腹泻属于中医学“泄泻”范畴。艾滋病患者长期受疫毒侵袭,伤及脾胃以致脾失健运,湿邪内阻,肠道分清泌浊、传导功能失司,清浊混杂而下,则大便溏泄。艾滋病相关慢性腹泻病机多为脾虚湿盛、寒热虚实错杂,病程常常迁延数日数月,必累及肾,继而导致脾肾两虚^[4-8]。艾滋病腹泻病位在肠,并与肝、脾、肾密切相关,反复发作,迁延不愈^[9]。

1 临床表现

腹泻是艾滋病发生发展过程中常见的一种并发症,在艾滋病中晚期占有很大比例,主要是患者感染 HIV 后,免疫系统功能下降而引发的消化系统症状,以便质稀溏或水样便,每日 3 次或以上为特征。根据病程又分为急性腹泻、慢性腹泻。艾滋病腹泻以慢性腹泻多见,其临床表现为腹泻便溏、脘闷食少、泻下清稀,甚则如水或间歇发作,迁延不愈,达数月或数年,日久体质质量下降,营养不良,形体枯萎,甚则形成恶液质状态以致死亡。

2 诊断要点

2.1 疾病诊断 根据 2018 年中华医学会感染病学分会艾滋病学组制定的《中国艾滋病诊疗指南(2018 年版)》^[10]中艾滋病的诊断标准和 2013 年《内科学》^[11]中慢性腹泻的诊断标准。有流行病学史,结合抗 HIV 阳性,经 Western Blot 确证试验证实;每天慢性腹泻次数均>3 次,每天粪便量增加>200 g,粪质稀薄(含水量>85%),腹泻持续时间均>4 周。可伴有不同程度的腹痛、纳呆、乏力、恶心呕吐及体质质量下降。电子肠镜检查排除肠道肿瘤和慢性溃疡性结肠炎患者。

2.2 证候诊断 参照《中医病证诊断疗效标准》制

定证候诊断标准。脾胃虚弱证:主症:大便时溏时泻,餐后易泻,夹有不消化食物,腹痛隐隐,脘闷不舒,胃纳呆滞;次症:神疲乏力,面色萎黄,肢体倦怠。舌淡胖苔白,脉细弱。寒热错杂证:久泻不止,或反复发作,大便稀薄,或呈水样,色褐而臭,可有黏液,肛门灼热,小便短赤,神疲纳呆,面色少华,舌质淡红。苔薄黄腻,脉细数而无力。脾肾阳虚证:主症:多在黎明前后,腹痛、肠鸣继而泄泻,泻后则安;次症:腰膝酸痛、腹部冷痛,得温痛减,形寒肢冷,溺清,不思饮食。舌淡胖而嫩,苔白滑,脉沉细无力。

3 治疗方案

3.1 西医基础治疗 补液,纠正脱水和电解质紊乱,纠正酸中毒等。如无必要,避免使用含蛋白酶抑制剂的抗病毒药物。对大便粪便检查有病原学证据者,加用相应的抗生素治疗。及时早期足量应用较新的抗菌药物如头孢菌素及氟喹诺酮类药物。对较重病情的腹泻患者可联合用药或根据药敏试验,选用敏感抗菌药物治疗。疗程较普通人的感染性腹泻时间要长,如志贺氏菌、空肠弯曲菌病程一般不少于 7 d,鼠伤寒沙门氏菌病程一般为 14 d。对鸟胞内分枝杆菌的感染,尚缺乏有效的治疗手段,目前治疗以新型大环内酯类药物为主。对痢疾阿米巴、贝氏芽胞子球虫、蓝氏贾第虫、圆线虫引起的腹泻,可用常规方法进行治疗。对于隐孢子虫腹泻的治疗尚未突破,尚缺乏有效的治疗手段。微生态制剂:培菲康(双歧杆菌三联活菌散)、益生菌、生态活菌素、奖灵水苏糖、整肠生等。对症治疗:奥曲肽、易蒙停、苯乙哌啶、蒙脱石散等。

3.2 中医治疗方案

3.2.1 辨证治疗 中药复方和中成药:①脾胃虚弱证:治法:健脾化湿。推荐方药:参苓白术散《太平惠民和剂局方》加减(推荐强度 B,证据级别 IV)。组成:党参、白术、茯苓、桔梗、山药、砂仁、白豆蔻、薏苡仁、扁豆、莲肉。推荐中成药:参苓白术散^[12](推荐强度 C,证据级别 IV)。②寒热错杂证:治法:清热散寒,辛开苦降,补气和胃,扶正祛邪。推荐方药:半夏泻心汤^[13](《伤寒论》)加减(推荐强度: B,证据级别 IV)。组成:清半夏、黄芩、黄连、党参、干姜、大枣、甘草。推荐中成药:乌梅丸(推荐强度 B,证据级别 I)。③脾肾阳虚证:治法:温补脾肾,固涩止泻。推荐方药:加味赤石脂禹余粮汤合四神丸加减^[14](推荐强度 B,证据级别 IV)。组成:赤石脂、禹余

粮、补骨脂、肉豆蔻、吴茱萸、五味子、乌梅、芡实、炒白术、茯苓、炒山药、炙甘草。推荐中成药: 四神丸(推荐强度 C, 证据级别 IV)。

3.2.2 非药物疗法 ① 艾灸治疗: 取神阙、关元、足三里(双侧), 顺序: 足三里、关元、神阙。配穴: 脾虚湿盛证配脾俞、胃俞、中脘; 寒热错杂配劳宫穴、脾俞、大肠俞; 脾肾阳虚配肾俞、命门^[5-17]。每穴灸 10~20 min, 灸至皮肤潮红为度。每天 1~2 次。维持治疗 1~2 个月。发烧时不可施灸。② 中药穴位贴敷神阙穴, 每天 1 次, 每次 2 h, 7 d 为 1 个疗程^[18]。

3.2.3 饮食疗法 药膳以扶正固本、补益气血为原则, 以粥类饮料为主。忌辛辣刺激、肥甘厚腻, 宜清淡、高蛋白饮食。脾肾亏虚者, 可服用山药、生姜、藕、蘑菇、大麦、粟米、玉米、黄豆、莲子等。

3.2.4 调摄 心理干预: 首先告诉患者通过检查分析排除器质性疾病, 确诊为艾滋病腹泻, 说明艾滋病腹泻的性质和预后, 调整患者的情绪和行为, 正确认知自己的病情, 树立战胜疾病的信心。建立合理规律的生活方式, 以改善患者的临床症状和生活质量。饮食调摄: 对患者饮食种类进行认真评估, 建议尽量避免产生胃肠不适的食物。针对泄泻患者, 在治疗期间, 应避免烟酒、辛辣肥甘食物的摄入, 忌咖啡、浓茶、生冷食物等。提肛: 提肛运动坐、卧和站立时均可进行。方法如下: 思想集中, 收腹, 慢慢呼气, 同时用意会有意识地向上收提肛门, 当肺中的空气尽量呼出后, 屏住呼吸并保持收提肛门 2~3 s, 然后全身放松, 让空气自然进入肺中, 静息 23 s, 再重复上述动作; 同样尽量吸气时收提肛门, 然后全身放松, 让肺中的空气自然呼出。每日 1~2 次, 每次 30 下或 5 min。此锻炼方法应长期坚持。

执笔单位: 云南省中医药研究院, 重庆市公共卫生医疗救治中心, 中国中医科学院艾滋病中心

中华中医药学会防治艾滋病分会参加本共识讨论及编写的成员名单: (按姓氏笔画排序)

万勇, 马成杰, 马建萍, 马秀兰, 王丹妮, 王军文, 王丽, 王莉, 王健, 毛宇湘, 邓鑫, 卢洪洲, 冯全生, 刘建忠, 刘颖, 许前磊, 苏琛, 李秀惠, 李鹏宇, 李鑫, 陆中云, 杨玉琪, 杨毅, 何云, 何金洋, 何艳, 谷野, 邹雯, 张传涛, 张国梁, 张明香, 张晓忠, 陈昕, 陈耀凯, 邵宝平, 林路平, 罗威, 和丽生, 胡建华, 姜枫, 徐立然, 高辉, 高国建, 郭会军, 黄成瑜, 常占杰, 梁碧颜, 董继

鹏, 蒋士卿, 喻剑华, 谭行华, 蔡怡, 洪兵

参考文献:

- [1] ATTILI S V, GULATI A K, SINGH V P, et al. Diarrhea, CD4 counts and enteric infections in a hospital-based cohort of HIV-infected patients around Varanasi, India [J]. BMC Infectious Diseases, 2006, 6(1): 39.
- [2] 焦炳欣, 王慧珠, 刘颖, 等. 艾滋病相关性慢性腹泻隐孢子虫感染患者的临床特征 [J]. 中华医学杂志, 2011, 91(37): 2611-2614.
- [3] 杨臻峰. 用于人类免疫缺陷病毒携带者及艾滋病患者的止泻药物 Crofelemer [J]. 药学进展, 2013, 37(1): 50.
- [4] 倪量, 万钢, 王融冰, 等. 311 例艾滋病相关慢性腹泻的中医证候特点研究 [J]. 北京中医药, 2011, 30(5): 323-326.
- [5] 倪量, 王融冰, 杨小平, 等. 艾滋病相关慢性腹泻的中医证候特点研究 [J]. 中国中药杂志, 2013, 38(15): 2476-2479.
- [6] 田明, 倪量, 万钢, 等. 健脾止泻方治疗艾滋病相关慢性腹泻的临床研究 [J]. 世界中医药, 2011, 6(3): 193-195.
- [7] 李卓, 袁君, 张晓伟, 等. 健脾止泻方治疗艾滋病相关腹泻脾肾阳虚证 19 例 [J]. 中医研究, 2016, 29(8): 11-13.
- [8] 时宗泽, 农惠玲, 周小青. 隔姜灸联合辨证施护对艾滋病腹泻患者生存质量的影响 [J]. 中西医结合护理(中英文), 2013, 3(7): 72-75.
- [9] 桑海艳, 谢世平, 武兴伟. 艾滋病腹泻病例回顾的因子分析 [J]. 光明中医, 2011, 26(3): 457-459.
- [10] 中华医学会感染病学分会艾滋病丙型肝炎学组, 中国疾病预防控制中心. 中国艾滋病诊疗指南(2018 年版) [J]. 中华内科杂志, 2018, 57(12): 867-884.
- [11] 葛均波, 徐永健. 内科学 [M]. 8 版. 北京: 人民卫生出版社, 2013: 402-405.
- [12] 杨国红, 崔敏, 周立华, 等. 参苓白术散治疗艾滋病相关性腹泻疗效观察 [J]. 中华中医药学刊, 2008, 26(1): 150-153.
- [13] 屈冰, 张明利, 张书亮. 半夏泻心汤治疗艾滋病相关腹泻 68 例 [J]. 中医研究, 2008, 21(8): 37-38.
- [14] 党中勤. 加味赤石脂禹余粮汤治疗艾滋病顽固性腹泻 56 例 [J]. 中国中医基础医学杂志, 2013, 19(7): 844-845.
- [15] 周立华, 李媛. 艾灸神阙、关元、足三里治疗艾滋病腹泻的机理研究 [J]. 光明中医, 2010, 25(4): 648-649.
- [16] 李静茹, 马建萍, 马秀兰, 等. 艾灸治疗脾胃虚弱型艾滋病腹泻临床观察 [J]. 世界科学技术——中医药现代化, 2016, 18(2): 237-240.
- [17] 农惠玲, 时宗泽. 隔姜灸治疗艾滋病腹泻的临床研究 [J]. 中国医药导报, 2016, 13(16): 101-103, 111.
- [18] 梅希玲, 杨玲, 郭淑梅. 中药外敷治疗艾滋病慢性腹泻 20 例 [J]. 中医临床研究, 2014, 6(9): 142, 144.

收稿日期: 2020-10-21

编辑: 纪彬